

血糖値の落とし穴！ 医師・生活者「血糖値・ヘモグロビン A1c に関する意識調査」

医師の 87% はヘモグロビン A1c、生活者の 69% は血糖値を重視

知名度ワースト『ヘモグロビン A1c』とは —— 医師と生活者の認識ギャップ

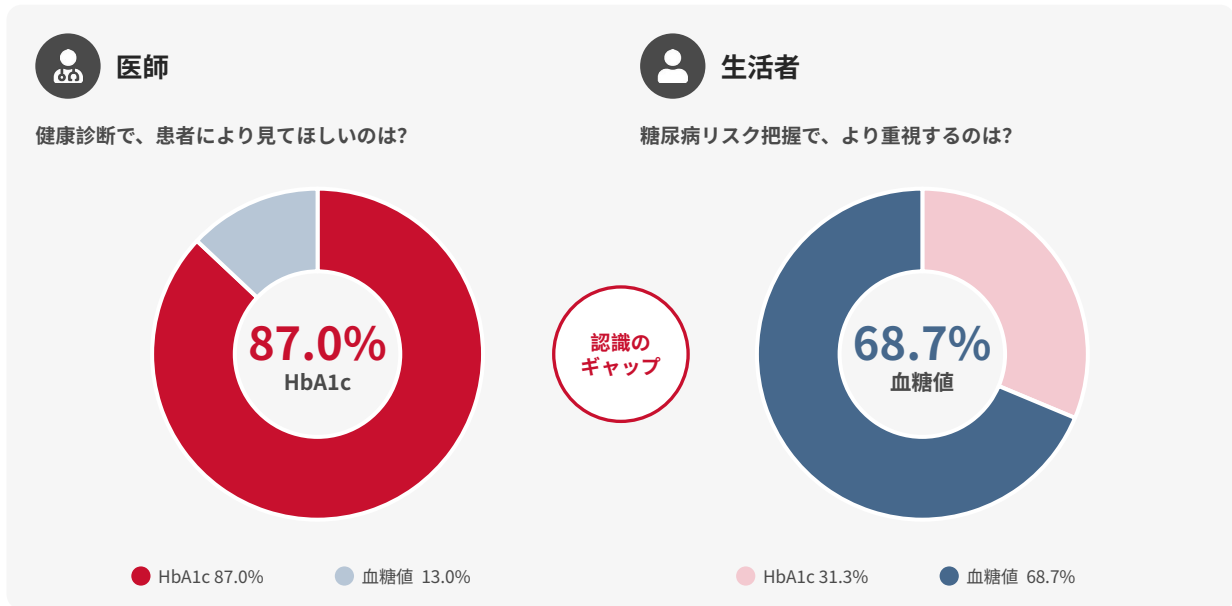
みなさん、正しく糖尿病対策を理解していますか？ 日本生活習慣病予防協会は「血糖値・ヘモグロビン A1c に関する意識調査（2026 年 9 月）」を医師 331 人、一般生活者 310 人に実施しました。『血糖値』が採血した瞬間の血糖の量を示す、1 日の中でも変動する指標であるのに対し、『ヘモグロビン A1c（HbA1c）』は過去 1～2 か月の血糖の状態を示す数値です。すぐには変動しないため“血糖の通信簿”とも呼ばれます。調査の結果、糖尿病のリスクを把握するうえで、医師と生活者の間に大きな認識のギャップがあることがわかりました。

キーワード

血糖値の落とし穴

／ 血糖の通信簿『ヘモグロビン A1c』

図 1 医師は HbA1c、生活者は血糖値 —— 「より見てほしい／より重視する」指標



調査結果のポイント

★ 78.2%

医師が HbA1c を「非常に重要」と回答

血圧に次いで 2 番目の高さ。一方、生活者の 40.3% は HbA1c を「知らない」（全指標中ワースト）

→ 図 2

📖 70.8%

HbA1c を「内容まで知っている」生活者は HbA1c を重視

「見聞きした程度」の人では 29.2%。名称だけでなく意味まで伝えることが鍵

→ 図 3

🔍 87.5%

生活者は「血糖値でリスクを十分に把握できる」と回答

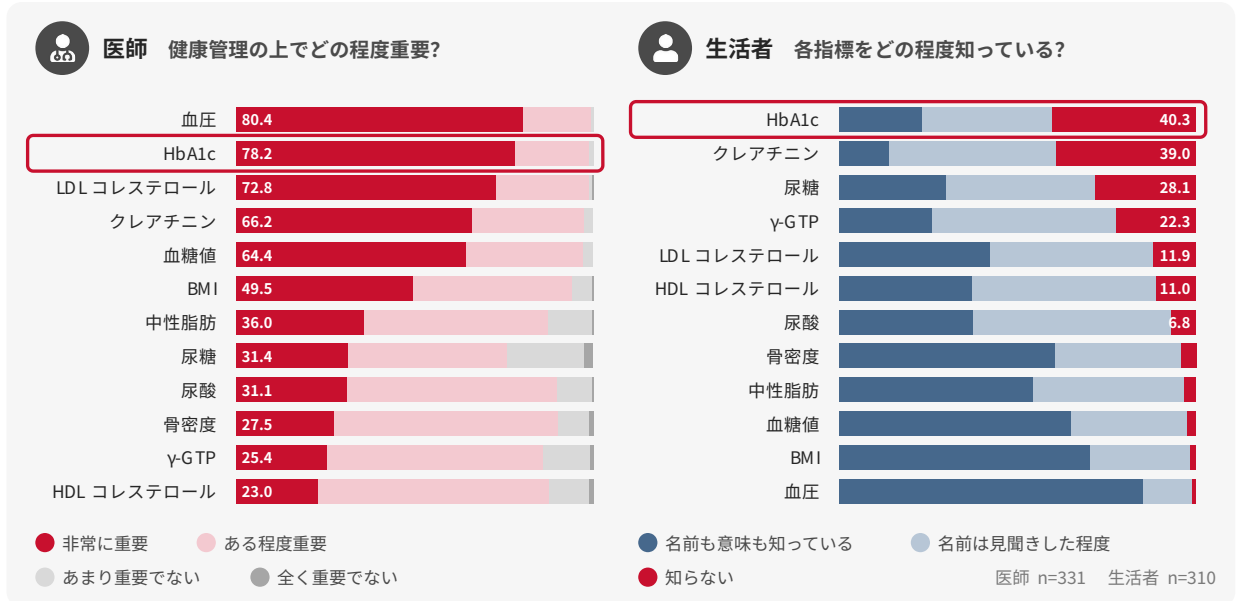
血糖値だけでは「予備群」を見逃す可能性も —— “血糖値の落とし穴”

→ 図 5

1 医師は HbA1c、生活者は血糖値 —— 糖尿病リスク把握の認識ギャップ

まず浮かび上がったのは、糖尿病リスクを把握する上で、医師と生活者の認識ギャップです（図 1）。医師に「健康診断で、患者により見てほしいのはどちらか」を尋ねたところ、87.0 %がヘモグロビン A1c と答えました。一方、生活者に「糖尿病のリスクを把握する上で、より重視するのはどちらか」を尋ねると、68.7 %が血糖値を重視すると答えました。

図 2 HbA1c は医師の 78.2% が「非常に重要」なのに、生活者の知名度はワースト



健康診断などで測定される指標への質問からも、大きなズレが浮き彫りになりました（図 2）。医師に「各指標が健康管理の観点でどのくらい重要か」を尋ねたところ、78.2 %がヘモグロビン A1c を「非常に重要」と答えました。血圧に続いて 2 番目の高さです（血糖値は 64.4 %で 5 番目）。一方、生活者に「各指標をどの程度知っているか」を尋ねると、ヘモグロビン A1c を「知らない」と答えた人は 40.3 %で、全指標の中でワースト。血糖値を知らない人は 2.3 %で、その差は歴然です。

2 HbA1c を「内容まで知っている」人の 7 割は HbA1c を重視

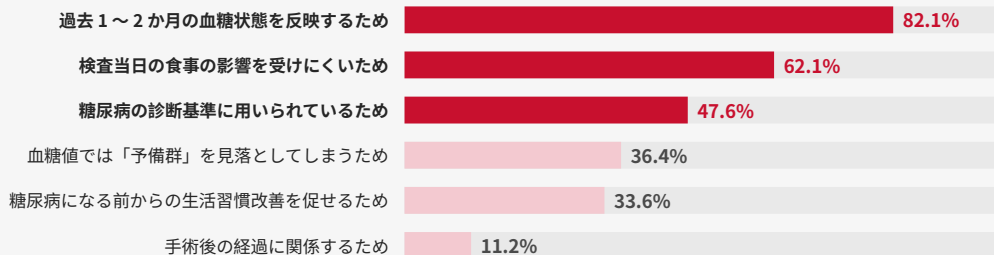
図 3 【生活者】糖尿病リスク把握で、より重視するのは？（ヘモグロビン A1c の認知度別）



さらに、図 1 で見た生活者の回答を、ヘモグロビン A1c の認知度別に分けて分析すると興味深い結果が出ました。「内容まで知っている人」の 70.8 %はヘモグロビン A1c を重視。一方、「見聞きしたことがある程度の人」でヘモグロビン A1c を重視と回答した人は 29.2 %でした（図 3）。ヘモグロビン A1c の認知拡大には、名称だけでなく、血糖値との違いや指標としての意味まで伝えることが重要であることがうかがえます。

3 なぜ医師はHbA1cを重視するのか

図4 【医師】HbA1cが重要だと思う理由は？（複数回答）



n=330（HbA1cを重要と回答した医師）

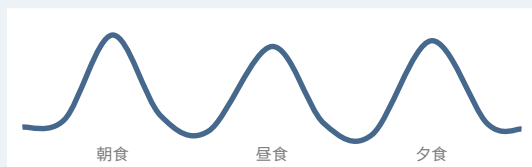
医師がヘモグロビンA1cを重視する理由を複数回答で選んでもらいました（図4）。最も多かったのは「過去1～2か月の血糖状態を反映するため（82.1%）」、続いて「検査当日の食事の影響を受けにくい（62.1%）」「糖尿病の診断基準に用いられているため（47.6%）」でした。

4 「血糖値」と「ヘモグロビンA1c」は何が違う？

血糖値

1日の中でも変動する

採血した“瞬間”の血糖の量



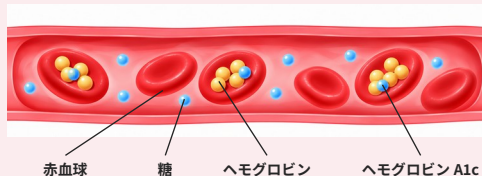
採血をした瞬間に血液の中にどれだけ血糖があるかを示す指標です。エネルギー源である血糖は、食事の直後に上がり、生活や運動で分解されて減り、また食事をすると上がる——この繰り返しのため、1日のうちでも数値は変動します。

一時的に血糖が跳ね上がる「血糖値スパイク」のある「糖尿病リスクの高い」人でも、食後10時間以上あけた「空腹時血糖値」は低く測定されることがあり、血糖値だけでは糖尿病の「予備群」を見逃す可能性も指摘されています。まさに「血糖値の落とし穴」です。

ヘモグロビンA1c

ほとんど変動しない

過去1～2か月の血糖の“通信簿”



血液中に取り込まれた糖の一部は赤血球の中に入り、ヘモグロビンと結合します。その結合した割合を示すのがヘモグロビンA1cです。一度結合すると、その赤血球が寿命を迎えるまで消えることなく蓄積されるため、血液中に糖が多い状態が長く続く人ほど数値が高くなります。

過去1～2か月トータル血糖の状態を反映しているため、血糖値と違い、検査当日の食事の影響を受けにくいのが特長です。

基準値



5 生活者の87.5%が「血糖値でリスクを十分に把握できる」

図5 【生活者】血糖値の測定やその数値で、糖尿病予備群などのリスクを十分に把握できる？

n=303

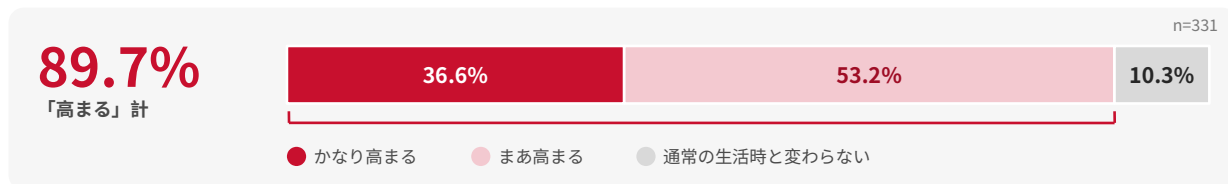
87.5%

「そう思う」計



生活者調査では、血糖値の測定やその数値によって、糖尿病予備群などのリスクを十分に把握できると思う人が87.5%にのびりました（図5）。血糖値が身近な指標であるからこそ、「血糖値を見ていれば大丈夫」と受け止められやすいことも、今回の“血糖値の落とし穴”といえそうです。

図6 【医師】通常の生活時と比べ、「災害時の避難生活」では血糖コントロールの重要性は高まる？



今年は、7月に発生した令和8年熊本地震や各地の豪雨災害など、大規模な災害が複数発生しています。災害時の避難生活では、食事の偏りや運動量の低下、生活リズムの乱れなどから血糖コントロールが難しくなることも考えられます。本調査で避難生活における血糖コントロールの重要性を医師に尋ねたところ、9割の医師が「重要性が高まる」と回答しました（図6）。



調査結果を踏まえて

日本生活習慣病予防協会 代表 東京慈恵会医科大学 客員教授 和田 高士

今回のアンケートにおいて、健康管理上の重要性として、医師が血圧の次にヘモグロビン A1c をあげたこと、これら以外の順位も、医師の立場からすると図星であった。一方、生活者対象の調査結果では、ヘモグロビン A1c が最下位であった。その理由は、健康診断では、糖尿病検査としては血糖かヘモグロビン A1c のいずれか実施でよいこと、空腹状態が必要な中性脂肪も同時実施するなら採血側が血糖を選択してしまうこと、その結果、生活者にヘモグロビン A1c を認知される機会が減るためと考えられました。ヘモグロビン A1c は変動する血糖と異なり、過去1～2か月の血糖平均状態を反映するため、糖尿病状態を容易に評価でき、健康管理には必須の血液検査項目です。

調査概要

調査名	血糖値・ヘモグロビン A1c に関する意識調査
調査主体	一般社団法人 日本生活習慣病予防協会
調査方法・期間	WEB 調査 2026 年 9 月
医師調査	全国の医師 331 人を対象に、健康診断項目の重要度、患者により確認してほしい指標、ヘモグロビン A1c を重視する理由などを調査
生活者調査	全国の 20 ～ 69 歳男女 310 人を対象に、健康診断項目の認知度、糖尿病リスク把握で重視する指標、ヘモグロビン A1c の認知度などを調査

日本生活習慣病予防協会とは

日本生活習慣病予防協会は、生活習慣病の一次予防を中心に、その成因、診断、治療、リハビリテーションに関する知識の普及啓発、生活習慣病に関する調査研究を行うことを目的に、2000年に設立。2012年より公益性を高めるため一般社団法人化致しました。設立当初より、健康標語『一無、二少、三多（いちむにしょうさんた）』（無煙、少食、少酒、多動、多休、多接）の健康習慣を提言し、2017年に1月23日を『一無、二少、三多の日』として記念日登録、2011年より毎年2月を「全国生活習慣病予防月間」として、『一無、二少、三多』の健康習慣の普及を図っています。役員は、医師を中心に構成されています。

<https://seikatsusyukanbyo.com/>



取材・調査内容のお問い合わせ

PR 事務局（株式会社 alma 内） 担当：和田、長瀬、石川
Tel：03-3519-3051 Email：almapr@alma11.com